

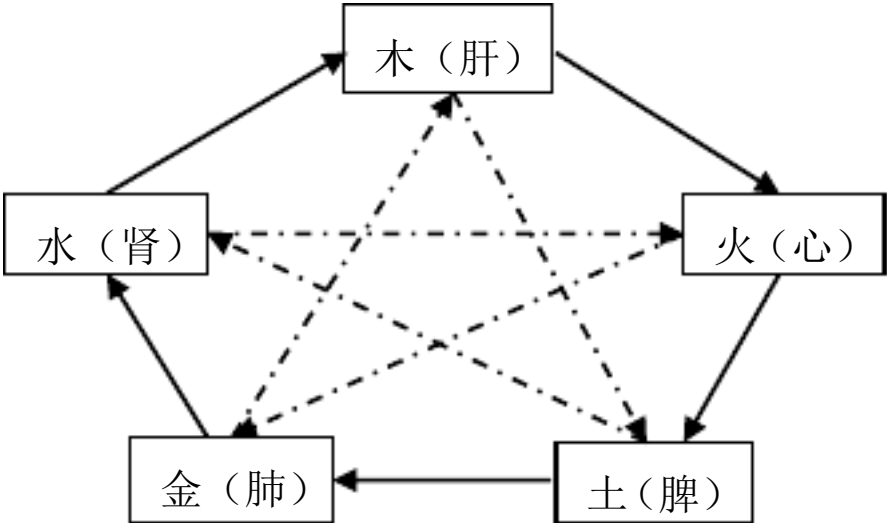
# 中医基础理论

## 一、绪论

- 1. 我国现存最早的医学巨著 《黄帝内经》
  - 2. 中医学论述辨证论治的第一部专著 张机“医圣”《伤寒杂病论》
  - 3. 我国现存最早的一部药物学典籍《神农本草经》
  - 4. 世界上最早的药典《新修本草》又名《唐本草》
  - 5. 第一部国家组织方书，处方规范著作《太平惠民和剂局方》
  - 6. 中医学理论体系的基本特点：1）整体观念 2）辨证论治
- 辨证：将四诊所搜集的症状，体征及其他资料，在中医理论指导下进行分析，辨清其原因、性质、部位、邪正关系，概括、判断为某种性质的症侯的识病方法。
- 论治：根据辨证的结果，确定相应的治疗方法。

## 二、阴阳五行

- 1. 阴阳：阴阳是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方的属性概括，既可以标识自然界相互关联而又相互对立的事物或现象的属性，又可以标识同一事物内部相互对立的两个方面。
- 2. 阴阳的特性：1）相关性 2）普遍性 3）相对性 4）属性的规定性
- 3. 阴阳的相互关系：1）对立制约[属性相对、相互制约] 2）互根互用[阴阳互藏、阴阳互根、阴阳互用] 3）消长平衡[此消彼长此长彼消、皆消皆长] 4）相互转化[渐变、突变]
- 4. 阴阳学说在中医学中的应用
  - 1) 说明人体的组织结构
  - 2) 解释人体的生理活动
  - 3) 解释人体的病理变化
    - i.阴阳偏胜：阳盛则热，阴胜则寒
    - ii.阴阳偏衰：阴虚则热，阳虚则寒
    - iii.阴阳互损
    - iiii.阴阳转化
  - 4) 指导疾病的诊断
  - 5) 知道疾病的防治
  - 6) 归纳药物的性能
- 5. 五行：对木、火、土、金、水五类事物属性的概括
- 6. 五行的特性：
  - 1) 木曰曲直：指树木具有能曲能直的生长特性。引申为凡具有生长、升发、舒畅、条达等作用或特性的事物，其属性可归纳为“木”。
  - 2) 火曰炎上：“炎”，有焚烧、灼热之意；“上”，即向上。“炎上”指火在燃烧时具有发光放热、蒸腾上升之象。引申为凡是具有温热、向上、升腾等作用或特性的事物，其属性可归纳为“火”。
  - 3) 土爰稼穡
  - 4) 金曰从革
  - 5) 水曰润下



7. 五行属性的归类：直接取象比类法，间接推演法

8. 五行的生克关系：

1) 相生：木、火、土、金、水之间存在着有序的递相资生、助长和促进的关系。五行的递资生的次序：木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。

2) 相克：木、火、土、金、水之间存在着有序的递相克制、制约关系。五行之间递相制约的次序：木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。

3) 相乘：相克太过，指五行中的某一行对其所胜一行的过度制约或克制，其顺序和方向与相克一致。

4) 相侮：反向制约，指五行中的某一行对其所不胜一行的反向制约或克制，又叫“反克”，或者“反侮”，其顺序和方向与相克相反。

9. 确立五脏疾病的治疗原则和方法：

1) 根据相生规律确立：虚则补其母，实则泻其子

2) 根据相克规律确立：抑强，扶弱

三、藏象：藏于体内的内脏所表现于外的生理、病理现象及相通应的自然事物和现象。

1. 五脏：心、肝、脾、肺、肾

五脏的共同生理功能特点：化生和贮藏精气

2. 六腑：胃、胆、小肠、大肠、膀胱、三焦

六腑的共同生理功能特点：受盛和传化水谷

3. 奇恒之腑：脑、髓、骨、脉、胆、女子胞

奇恒之腑的共同生理功能特点：贮藏精气

4. 心

1) 生理特性：心在五脏中居于首要地位，对脏脏功能活动起着主宰的作用。

2) 主要生理功能：

i.主血脉。心能推动血液运行。

ii.主藏神。心主管生命和精神活动的的能力。

3) 与形体官窍的联系：在体合脉，其华在面，开窍为舌，在液为汗，在志为喜。

5. 肺

1) 生理特性：肺为娇脏。又称华盖之脏。肺气运动的特点是宣发和肃降。

2) 主要生理功能：

i.肺主气，司呼吸。肺具有主管一身之气和呼吸之气的功能。

ii.肺主宣发与肃降。肺气既具有向上宣升和向外布散的功能，又具有向下通降和保持呼吸道洁净的功能。

宣发：排浊气；向上输布津液和水谷精微；宣发卫气；将会聚于肺的血液经清浊之气交换后布散全身。

肃降：吸清气；向下输布津液和水谷精微；清除肺和呼吸道的异物；洁净血液；有利于大肠的向下传导糟粕。

iii.助心行血。肺朝百脉，指全身的血液经过血脉汇聚于肺，血液的循行虽然主要依靠心气的推动，但心气的盛衰与宗气密切相关，宗气“贯心脉”助心行血，正是通过肺朝百脉而实现的。

iiii.肺主通调水道。肺具有促进水液输布和排泄的功能。

3) 与形体官窍联系：在体合皮，其华在毛，开窍于鼻，喉为肺之门户，在液为涕，在志为悲（忧）。

## 6. 脾

1) 生理特性：喜燥恶湿，主升。脾为后天之本。气血生化之源。

2) 主要生理功能：

i.脾主运化。主管饮事物的消化、吸收、转输的功能。包括运化水谷和运化水液两方面

ii.脾主升。含升清、升举两个意思。

iii.脾主统血。即脾具有统摄血液的功能。

3) 与形体官窍联系：在体合肉，主四肢，开窍于口，其华在唇，在液为涎，在志为思。

## 7. 肝

1) 生理特性：体阴用阳，其性刚，主动主升。

2) 主要生理功能：

i.肝主疏泄。肝具有疏通全身气机，使之调畅的功能。

(调畅精神情志。

维持气血运行。

促进脾胃消化吸收与输布。

促进水液代谢。

调节生殖功能。)

ii.肝藏血。肝具有贮藏血液、调节血量和防止出血。

3) 与形体官窍联系：在体合筋，其华在爪，开窍于目，在液为泪，在志为怒。

## 8. 肾

1) 生理特点：肾藏精，肾为先天之本。

2) 主要生理功能：

i.主藏精。主生长发育与生殖；推动和调节脏腑气化。

ii.主水液。主管水液代谢的功能。一是温煦和推动肺脾等脏对水液代谢的调节；二是肾气、肾阳对水液代谢的调节是通过“蒸腾气化”“升清降浊”来实现的；三是司膀胱的开合，排泄尿液。

iii.主纳气。肾具有摄纳肺所吸入的清气，以防止呼吸表浅的功能。

3) 与形体官窍联系：在体合骨，齿为骨之余，其华在发，开窍于耳及前后阴，在液为唾，在志为恐。

9. 脏与腑的关系：1) 心与小肠 2) 肺与大肠 3) 脾与胃 4) 肝与胆 5) 肾与膀胱

## 四、精、气、血、津液

### 1. 精

1) 精的生成：禀受于父母，充实于水谷，主要藏于肾。(先天之精：禀受于父母的生殖之精+水谷精气，后天之精：水谷)

2) 精的主要功能：

i.生殖繁衍

ii.促进生长发育

iii.生髓、充脑、养骨、化血

iiii.滋养濡润

iiiii.防御卫外

### 2. 气

1) 气的生成：

i.气的来源：先天之精气(禀受于父母生殖之精)；后天水谷之精气(饮食物化生而成)；后天自然界清气(通过呼吸而得)。以上先后天之气结合起来，就生成为人体的气，又称真气。

ii.气生成与脏腑的关系：与肾、脾胃、肺关系密切。肾藏精，脾胃主运化，肺主呼吸。

## 2) 气的主要功能：

i.推动作用：气是活力很强的精微物质，能促进人体的生长、发育、激发和推动各脏腑、经络等组织器官的生理活动；能推动血液的生成、运行、以及津液的生成、输布和排泄等。

ii.温煦作用：气的温煦作用是指通过运动变化能够产生热量，温煦人体。

iii.防御作用：气的防御作用是指气有护卫肌肤，抗御邪气的功能。

iiii.固摄作用：气的固摄作用主要是指气对血、津液等液态物质具有固护统摄和控制，防止其无故流失的功能。

iiiii.气化作用：气化是指通过气的运动而产生的各种变化，具体而言指气具有促进精、气、血、津液各自的新陈代谢及其相互转化的功能。

iiiii.营养作用：人体之气分布于全身各脏腑组织中，为各脏腑器官提供必需的营养成分。

## 3) 气的分类：

i.元气：功能特点：推动人体生长、发育和生殖。激发推动脏腑、经络等组织器官的生理功能活动。

ii.宗气：生成：由肺吸入的大自然之清气和由脾胃运化食物所得的水谷精气在胸中结合而成。

分布：积聚于胸中，贯注于心肺。

功能特点：走息道以行呼吸，呼吸的强弱与宗气盛衰有关。贯心脉以行气血，主要体现在助心行血。与人的视、听、言、动等相关。

iii.营气：功能特点：营养全身。化生血液。

iiii.卫气：生成：来自于脾胃化生的水谷精气，是水谷精气中性质彪悍，运行滑利，反应迅速的部分。

分布：内而脏腑，外而肌肉皮肤，行于脉外，布散于全身，偏于肌表。

功能特点：护卫肌表，防御外邪入侵。温养脏腑、肌肉、皮毛。开合汗孔，调节体温。影响睡眠。

## 3. 血

### 1) 血的生成：

i.饮食物经过脾胃运化化生为水谷之精，上输心肺，变化为赤而成血。

ii.肾藏精，骨生髓，精髓化生为血。

iii.津液充盈脉内。

iiii.自然界的清气与营气相结合，贯注于心脉。

### 2) 组成：营气和津液是生成血的最基本物质。

### 3) 血的功能：

i.濡养作用（五脏对血液生成的作用）

ii.运载作用（清气水谷精气，浊气浊物，传递信息）

iii.精神活动的物质基础

### 4) 血的运行：血液在脉等中运行，流行不止，环周不止

## 4. 津液

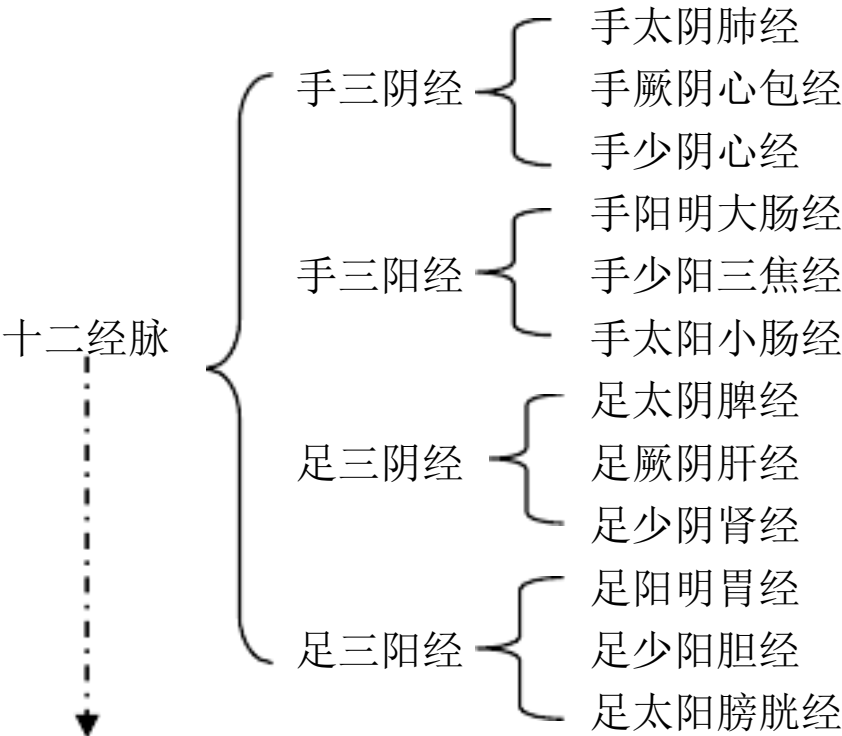
1) 津液：机体一切正常水液的总称，包括各脏腑组织内在体液及正常的分泌物。在机体内除血液之外的其他所有正常液体都属于津液。

2) 津液的代谢依赖于肺、脾、肾等。

3) 津液的功能：i.滋养和营养作用 ii.化生血液作用 iii.运载作用

气与血的关系：气属阳，主煦之；血属阴，主濡之。  
气为血帅：1) 气能生血（气参与并促进血液的生成） 2) 气能行血（气的推动作用使血液循行的动力） 3) 气能摄血（血在脉中运行而不逸出脉外）  
血为气母：4) 血能载气（血能化气，血盛则气旺） 5) 血能化气（血液具有运载水谷精气，自然清气的功能）

5. 十二经脉



十二经别——从十二经脉别出的最大分支

6. 体质

- 1) 体质：又称素质、禀质、禀赋，是人体遗传性和获得性基础上表现出来的生理机能、形态结构和心理活动方面综合的相对稳定的固有特性。
- 2) 影响因素：先天禀赋 年龄因素 性别差异 饮食因素 劳逸所伤 情志因素 地理因素 疾病针药及其他因素
- 3) 体质的分类：
  - i. 阴阳平和质：功能较协调的体质类型
  - ii. 偏阳质：具有亢奋、偏热、多动等特点的体质类型
  - iii. 偏阴质：具有抑制、偏寒、多静等特点的体质类型

六、病因

(一) 外感病因：

- 1. 六淫：风邪、寒邪、暑邪、湿邪、燥邪、热（火）邪

共同特点：外感性、季节性、环境性、相兼性、转化性

- 1) 风邪：性质：轻扬开泄、善行数变、动摇不定、多兼他邪  
致病特点：易于侵袭阳位（头面-口眼歪斜，肺-鼻塞流鼻涕）；病位游移不定（风疹，荨麻疹）；发病急骤、变化无常（小儿风水病）；肢体异常运动（“破伤风”症状）；常为外邪治病的先导（风寒，风湿，故“风为百病之长”）
- 2) 寒邪：性质：寒凉、凝滞、收引  
致病特点：易伤阳气、表现寒象（脾吐泻清稀，精神萎靡）；阻滞气血、多见疼痛（脘腹冷痛或绞痛）；腠理、经脉、筋脉收缩拘（肢体关节屈伸不利，冷厥不仁）
- 3) 湿邪：性质：重浊、黏滞、趋下  
致病特点：易于损伤阳气；易于阻遏气机；易于侵袭阴位；病程缠绵难愈；多见头身肢体困重；排泄物和分泌物秽浊不清、黏滞不爽



4) 热（火）邪：性质：燔热、炎上、急迫

致病特点：表现阳热之象（面赤，烦躁）易于伤津耗气（乏力）；主要侵犯人体上部（头痛，耳鸣）；易致生风动血（吐血，便血）；易扰心神（心烦失眠）；易致阳性疮痈（阳性疮疡）

2. 疫气：泛指一类具有强烈传染性和致病性的外感病邪。又称“戾气”、“疫疠”

（二）内伤病因

1. 七情内伤

致病特点：1) 直接伤及内脏 2) 影响脏腑气机：怒则气上、喜则气缓、悲则气消、恐则气下、惊则气乱、思则气结 3) 情志波动，影响病情

2. 饮食失宜：1) 饮食不节 2) 饮食不洁 3) 饮食偏嗜

3. 劳逸过度

（三）病理产物性致病因素：

1. 痰饮：机体水液代谢障碍所形成的病理产物，属于激发病因之一。

致病特点：1) 阻滞气机，阻碍气血运行 2) 易扰心神 3) 症状复杂，变化无端 4) 病势缠绵，病程较长

2. 瘀血：血液运行障碍、停滞所形成的病理产物，属于继发病因。包括离经之血停积体内，以及阻滞于脏腑经络内的运行不畅的血液。

致病特点：1) 瘀血致病的病机特征：阻滞气机；淤塞经脉；伤及脏腑

2) 瘀血致病的症状特征：疼痛（多为刺痛，痛处固定，拒按，夜间加重）肿块（按之有形，质地较硬，固定不移）；出血（血色多为紫暗，或夹有瘀块）；紫绀（面部、爪甲、肌肤、口唇青紫）；舌象（舌质紫暗，或有瘀点，或舌下静脉曲张）；脉象（脉细涩，沉弦，或结代/涩、迟、沉、弦）

3. 结石

七、病机

重要依据——“取象比类”，主要方法——“审证求因”

1. 发病的基本原理：

1) 正气：简称“正”，与邪气相对而言，泛指人体的各种物质结构（脏腑、经络、精气血津液等），是产生生理机能、抗病能力和康复能力的物质基础。

2) 邪气：简称“邪”，泛指各种致病因素，包括六淫、疫疠邪气、七情内伤、劳逸损伤及各种病理产物（如痰饮、水湿、瘀血、结石、宿食）等。

2. 发病形式：

1) 感而即发：新感外邪，疫疠邪气致病，情志骤变，中毒，急性外伤

2) 伏而后发：破伤风，狂犬病，艾滋病

3) 徐发：湿邪致病

4) 继发：肝病，胁痛，黄疸——“癥积”“膨胀”，小儿脾胃虚弱——“疳积”

5) 复发：疾病复发的因素：食复、劳复、药复、重感复、其他因素致复、自复

特点：原有疾病的基本病理变化和主要病理特征的重现；较原病加重且越来越复杂；与一定的诱发因素有关

八、诊法

1. 正常舌象：淡红舌薄白苔

2. 问现在症状：

1) 问寒症：但寒不热；但热不寒；恶寒发热；寒热往来

## 2) 问出汗:

i.自汗: 经常汗出不止, 活动后有甚者, 称为自汗。多源于阳气虚弱, 腠理不密, 津液无以固摄而外泄, 常伴有神疲乏力, 气短懒言症。

ii.盗汗: 入睡时出汗, 醒后则汗止者, 谓之盗汗。多因阴虚不能制阳而阳偏盛, 虚热蒸发津液外出为汗, 常伴有潮热、红及舌红少苔等症。

iii.战汗

iiii.绝汗

## 3) 问疼痛: 疼痛性质

i.胀痛、走窜痛: 多见于气滞

ii.刺痛: 多见于瘀血

iii.冷痛: 多见于寒邪或阳虚

iv.灼痛: 多见于火邪或阴虚阳亢

v.绞痛: 多见于瘀血, 蛔虫, 结石

vi.隐痛: 多见于虚证

vii.重痛: 多见于湿邪

viii.掣痛: 多见于血虚或寒邪

ix.酸痛: 多见于湿邪或肾虚

## 3. 正常脉象: 健康人的脉象称为正常脉象, 又称平脉、常脉。

平脉特点: 平脉具有胃神根三个特点, 所谓脉有胃气, 是指脉象从容和缓, 节律一致; 所谓脉有神, 即脉象柔和有力, 形体指下分明; 所谓脉有根, 即指沉取尺部, 脉应指有力。

## 九、辨证 (六经辨证: 叶桂 (叶天士), 伤寒辨证: 张仲景)

### 1. 八纲辨证

#### 1) 表里辨证: 辨证疾病病位和病势趋向的两个纲领。

表证: 指六淫等外邪经皮毛、口鼻侵入时所产生的证候。

临床表现: 恶寒 (或恶风) 发热, 头身疼痛, 鼻塞流涕, 咽喉痒痛, 咳嗽, 舌苔薄白, 脉浮。

辨证要点: i.本证以外邪袭表, 卫气被郁为主要病机。

ii.为外感病的初级阶段, 有起病急、病程短的特点。

iii.以恶寒发热并见苔薄白、脉浮为辨证依据。

iv.可见鼻塞流涕、咽喉痒痛、咳嗽, 甚至喘促等肺气失宣的兼证。

#### 2) 寒热辨证: 辨证疾病性质的两个纲领。

热证: 指感受热邪, 或机体阴虚、阳亢所表现的证候。

临床表现: 各类热证表现不尽一致, 常见的有: 恶热喜冷, 口渴喜冷饮, 面红耳赤, 烦躁不宁, 痰、涕黄稠, 吐血, 大便干, 尿少色黄, 舌红苔黄而干, 脉数等。

辨证要点: i.本证以阳热亢盛或阴虚内热为主要病机。

ii.以发热、恶热喜凉、面红、舌红苔黄、脉数等证候为辨证依据。

iii.热伤津液, 故渴喜冷饮、大便干、尿少色黄、舌干少津等症状亦可作为辨证的参考依据。

iv.热伤血络, 迫血妄行, 故吐血等血症状亦可见之。

v.寒证热证的鉴别: 辨证寒证与热证, 不能孤立地根据某一症状做判断, 应对疾病的全部表现进行综合观察。

#### 3) 虚实辨证: 辨证邪正盛衰的两个纲领。

#### 4) 阴阳辨证: 辨别证候类别的纲领。

阳证: 表证、热证、实证

阴证: 里证、虚证、寒证

## 2. 气血津液阴阳病辨证

1) 气病辨证：症状：气虚、气陷、气滞、气逆

2) 血病辨证：症状：血虚、血瘀、血热、血寒

3. 外感病辨证：六经辨证，卫气营血辨证，三焦辨证

## 十、养生，防治，康复

1. 养生的基本原则：顺其自然，形神兼养，动静结合，调养脾胃。

2. 预防：未病先防，既病防变。

3. 标本先后：标与本是一个相对的概念，常用来说明疾病过程中的各种矛盾关系。以发病先后而言，先发之病为本，后发之病为标；以病因与症状而言，病因为本，症状为标。

1) 急则治标：标病或标症甚急，有可能危及患者生命或影响本病治疗时所采用的一种治疗原则。

2) 缓则治本：标病或标症缓而不急时所采用的一种治疗原则。

3) 标本兼治：标病与本病错杂并重时采取的一种治疗原则。

4. 正治和反治：在“治病求本”根本原则指导下，针对病证有无假象而制定的两种治疗原则。

1) 正治：指治疗用药的性质，作用趋向逆病证表象而治的一种常用治则，适用于本质与现象相一致的病证。

方法：寒者热之，热者寒之，虚则补之，实则泻之。

2) 反治：指所用药物的性质，作用趋向顺从病症的某些表象而治的一种治则，适用于本质与现象不完全一致的病证。

方法：热因热用，寒因寒用，塞因塞用，通因通用。

5. 因人、因时因地制宜：三因：因人、因时、因地

6. 康复的基本原则：形神结合，内外结合，药食结合，自然康复与治疗康复结合